Клинические рекомендации

Хронический средний отит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H65.2** — Хронический серозный средний отит **H65.3** — Хронический слизистый средний отит **H65.4** — Другие хронические негнойные средние отиты **H66.1** — Хронический туботимпанальный гнойный средний отит **H66.2** — Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит **H66.3** — Другие хронические гнойные средние отиты **H72.0** — Центральная перфорация барабанной перепонки **H90.0** — Кондуктивная потеря слуха двусторонняя **H90.1** — Кондуктивная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе **H90.2** — Кондуктивная потеря слуха неуточненная **H90.6** — Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость двусторонняя **H90.7** — Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость односторонняя, с нормальным слухом на противоположном ухе **H90.8** — Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость неуточненная
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 29.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/698_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 4

3.1 Жалобы и анамнез 5

3.2 Физикальное обследование 5

3.3 Степени мукозита по данным отоскопии 5

3.4 Исследование слуха 6

3.5 Инструментальные исследования 6

3.6 Лабораторные исследования 7

3.7 Консультации специалистов 8

4. Лечение 8
4.1 Консервативное лечение 8
4.2 Хирургическое лечение 9
4.3 Санирующие операции при холестеатоме 10
4.4 Слухопротезирование 11
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 11
5.1 Показания к госпитализации и выписке 11
6. Источник и актуальность 12
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 12

1. Основные положения

- Основным методом лечения хронического гнойного среднего отита является хирургический, и каждый пациент с этим заболеванием рассматривается как потенциальный кандидат на операцию. Оперируют в период ремиссии, не ранее чем через 3–6 месяцев после последнего обострения.
- При диагностике всем пациентам выполняют тональную пороговую аудиометрию, позволяющую определить степень и вид тугоухости и прогнозировать результат операции. При порогах костной проводимости выше 30 дБ в диапазоне разговорных частот качественного улучшения слуха не следует ожидать даже после безупречно выполненной операции.
- При подозрении на холестеатому или её рецидив показана магнитно-резонансная томография (МРТ) височных костей: в режимах Т1, Т2 и диффузионно-взвешенных изображений метод позволяет отличить холестеатому от секрета, грануляций и холестероловой гранулемы.
- В консервативном лечении основная роль принадлежит местным средствам: антисептикам, ушным каплям с противомикробными препаратами и кортикостероидами. Топические фторхинолоны не обладают ототоксичностью и допустимы при перфорации барабанной перепонки. Местное лечение эффективно только после тщательного удаления содержимого из среднего уха аспирацией или промыванием.
- Неоперированные пациенты осматриваются раз в 6 месяцев, пациенты после тимпанопластики или санирующей операции ежегодно на протяжении не менее 5 лет; это позволяет своевременно выявить рецидив перфорации, холестеатомы и тугоухости.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Хронический гнойный средний отит (ХГСО) характеризуется хроническим воспалением полостей среднего уха со стойкой перфорацией барабанной перепонки, постоянным или периодическим гноетечением из уха и прогрессирующим снижением слуха на протяжении более 3 месяцев.

Мукозитом называется хроническое катаральное воспаление слизистой оболочки среднего уха. Тимпаносклероз является необратимым исходом неспецифического воспаления и сопровождается тугоухостью вследствие фиксации звукопроводящей цепи. Тимпанофиброз представляет собой незавершённый процесс, при котором в барабанной полости фиброзирование преобладает над воспалением. Холестеатома является белесовато-перламутровым эпидермальным образованием с оболочкой (матриксом), покрытой многослойным плоским эпителием; матрикс плотно прилежит к кости и нередко врастает в неё.

2.2 Этиология

У взрослых ХГСО развивается на фоне хронических заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки, после перенесённых острых средних отитов, при системной и специфической патологии. Пусковым фактором, как правило, является острый средний отит, после которого сохраняется стойкая перфорация или ретракция с атрофичной неомембраной, а также травматическая или ятрогенная перфорация; после врачебных манипуляций перфорация сохраняется у 1,3–10,8% пациентов.

Хронизации процесса способствуют анатомические особенности среднего уха и слуховой трубы, неадекватная антибактериальная терапия острого отита без дренирования среднего уха, устойчивые штаммы возбудителей, ретракция после острого отита, экссудативный средний отит, снижение местной иммунной защиты, а также заболевания носоглотки и полости носа, нарушающие мукоцилиарный клиренс слуховой трубы.

Ведущим возбудителем среди аэробов является синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), второе место по значимости занимает золотистый стафилококк. Из анаэробов чаще высеваются пептококки и пептострептококки, реже бактероиды; анаэробная флора чаще сопутствует холестеатоме. В 1,4–20% случаев выявляется грибковая флора, как правило Aspergillus и Candida.

2.3 Классификация

Согласно МКБ-10 выделяют две формы ХГСО: мезотимпанит (туботимпанальный отит) и эпитимпанит (эпитимпано-антральный отит). При мезотимпаните поражается преимущественно слизистая оболочка мезо- и гипотимпанума, при эпитимпаните процесс распространяется из эпитимпанума на клетки сосцевидного отростка и вовлекает костные структуры среднего уха.

Согласно клинико-морфологической классификации хронический средний отит подразделяется на неперфоративный и перфоративный. К неперфоративным формам относятся экссудативный и адгезивный (рубцовый) отит, отит с тимпаносклерозом или тимпанофиброзом; к перфоративным формам относятся сухой отит, отит с мукозитом, с тимпаносклерозом или с холестеатомой.

Расположение перфорации отражает лишь преимущественную локализацию воспалительного процесса и не позволяет судить об изменениях в среднем ухе: даже при мезотимпаните разрушение цепи слуховых косточек выявляется у 10–22% пациентов, а холестеатома в барабанной полости у 11,6–42%. Поэтому для планирования операции необходима диагностика этих изменений.

Классификация Европейской академии отологии и нейроотологии и Японского отологического общества (EAONO/JOS) выделяет 4 типа холестеатомы (врождённая холестеатома, холестеатома ненатянутой части, холестеатома натянутой части барабанной перепонки и вторичная холестеатома при перфорации натянутой части) и 4 стадии: 1-я стадия соответствует поражению одного региона, 2-я стадия поражению двух и более регионов, 3-я стадия наличию внечерепного осложнения, 4-я стадия наличию внутричерепного осложнения. Регионы обозначаются по системе STAM: труднодоступные зоны (надтубарный и тимпанальный синусы), барабанная полость, аттик и сосцевидный отросток.

2.4 Клиническая картина

Пациенты предъявляют жалобы на снижение слуха и шум в ухе; при отоскопии определяется перфорация барабанной перепонки с отделяемым или холестеатомой.

Мезотимпанит характеризуется перфорацией в натянутой части барабанной перепонки и встречается у 48–69% больных ХГСО. Эта форма считается относительно благоприятной, поскольку признаки активной остеодеструкции отсутствуют.

Эпитимпанит встречается у 15–19% больных; перфорация располагается в ненатянутой части барабанной перепонки, в среднем ухе протекает кариозный процесс, способный привести к лабиринтным и внутричерепным осложнениям. В 79–97% случаев деструкция кости обусловлена холестеатомой. Ретракционный карман рассматривается как начальная стадия холестеатомы: в 80% случаев она развивается именно из него.

Эпимезотимпанит выявляется у 17–33% пациентов и сочетает признаки обеих форм.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании совокупности жалоб, данных анамнеза, физикального обследования, лабораторных и инструментальных исследований.

3.1 Жалобы и анамнез

Необходимо уточнить наличие снижения слуха на одно или оба уха.

Снижение слуха отмечается у 93–99% пациентов, чаще двустороннее. При длительном течении заболевания с формированием тимпаносклероза, тимпанофиброза и ретракционного кармана тугоухость становится выраженной.

Следует уточнить длительность, частоту и характер выделений из уха.

Оторея является второй по значимости жалобой и встречается у 76–100% пациентов. Около половины пациентов отмечают выделения 1–2 раза в год после переохлаждения, попадания воды в ухо или острого респираторного заболевания (ОРЗ), почти треть указывает на частые или постоянные выделения в последние годы. Характер выделений варьирует от скудных слизистых до гнойных с ихорозным запахом.
Редкие обострения на фоне выраженной тугоухости характерны для тимпаносклероза, тимпанофиброза и холестеатомы, постоянное отделяемое характерно для мукозита, гнойное отделяемое с неприятным запахом характерно для холестеатомы. Опасность эпитимпанита заключается в длительном бессимптомном течении.

Необходимо уточнить наличие шума в одном или обоих ушах.

Шум в ухе беспокоит 19–48% пациентов. Низкочастотный шум, как правило, связан с дефектом барабанной перепонки, высокочастотный шум связан с поражением внутреннего уха. При тимпаносклерозе и тимпанофиброзе шум усиливается.

Следует уточнить наличие заложенности, ощущения жидкости и дискомфорта в ухе.

Подобные жалобы чаще встречаются при сохранённой натянутой части барабанной перепонки.

Необходимо выяснить, отмечались ли эпизоды головокружения в анамнезе.

Системное головокружение или неустойчивость встречаются у 10–27% больных с холестеатомой и возникают при обострении, нагрузке, наклонах и поворотах головы. В половине случаев эти симптомы свидетельствуют о фистуле лабиринта. При деструкции стенки канала лицевого нерва возможен его парез.

Следует уточнить наличие головной боли.

Головная боль различной локализации часто возникает при обострении. Для неосложнённого эпитимпанита боль в ухе и головная боль не характерны; их появление, как правило, свидетельствует о развитии осложнения.

3.2 Физикальное обследование

Всем пациентам показана отоскопия или видеоотоскопия; при ХГСО этот метод наряду с отоэндоскопией является определяющим в диагностике.

Оцениваются состояние барабанной перепонки (тонкая, утолщённая, рубцовая, очаги тимпаносклероза), наличие и глубина ретракционных карманов, размер и локализация перфорации, состояние её краёв, слизистая оболочка барабанной полости (мукозит, тимпаносклероз, полипы, грануляции, эпидермизация), доступные осмотру слуховые косточки (кариес, лизис), латеральная стенка аттика и адитус.

3.3 Степени мукозита по данным отоскопии

Степень	Изменения слизистой оболочки
I	Слизистая оболочка медиальной стенки барабанной полости утолщена, свободное отделяемое отсутствует
II	Подушкообразное утолщение слизистой оболочки медиальной стенки с большим количеством слизистых желёз, скудное слизистое отделяемое
III	Выраженная полиповидная гиперплазия слизистой оболочки мезогипотимпанума, слизистое отделяемое

При отоэндоскопии холестеатома визуализируется в 61% случаев. При эпитимпаните перфорация может быть точечной, определяться только при продувании, прикрываться серной коркой или временно отсутствовать в период стойкой ремиссии; в этих случаях необходим тщательный осмотр латеральной стенки аттика для выявления даже минимальной деструкции. В ряде случаев заболевание протекает под маской рецидивирующего экссудативного отита, и за прозрачным экссудатом определяется холестеатомный мешок при небольшом ретракционном кармане в ненатянутой части. Для осмотра глубоких карманов применяются эндоскопы с углом обзора 0°, 30° и 70°.

Распознать фистулу лабиринта позволяет фистульная проба.

Проходимость слуховой трубы оценивается с помощью пустого глотка, пробы Тойнби, приёма Вальсальвы или продувания баллоном Политцера. Чем более выражен мукозит, тем хуже вентиляционная и дренажная функции слуховой трубы. Дисфункция слуховой трубы может объяснять ретракцию барабанной перепонки до операции и в отдалённом послеоперационном периоде и учитывается при хирургическом лечении и реабилитации. При нормальной функции слуховой трубы у пациента с хроническим серозным отитом следует заподозрить спонтанную отоликворею.

Необходима оценка состояния полости носа, околоносовых пазух и носоглотки: искривление перегородки носа, гипертрофический ринит, хронические заболевания околоносовых пазух и носоглотки нарушают функцию слуховых труб и снижают эффективность лечения.

3.4 Исследование слуха

При подозрении на снижение слуха показано камертональное исследование слуха.

Количественные (камертоны С128–2048) и качественные (С128–512) пробы Ринне, Федериче и Вебера являются скрининговым методом, позволяющим определить вид тугоухости (кондуктивная или сенсоневральная) и хуже слышащее ухо. По их результатам составляется слуховой паспорт; они же служат показанием к тональной пороговой аудиометрии.

При диагностике ХГСО показана тональная пороговая аудиометрия (ТПА).

ТПА позволяет точно определить степень и вид тугоухости (кондуктивная, смешанная или нейросенсорная) и возможности реабилитации, прогнозировать результат операции и контролировать его в отдалённом периоде. При порогах костной проводимости выше 30 дБ в диапазоне разговорных частот качественного улучшения слуха не следует ожидать даже после идеально выполненной операции. Динамику предпочтительно оценивать на одном и том же аудиометре, исследование должен проводить один и тот же специалист.

Для ХГСО характерна кондуктивная и смешанная тугоухость; её степень зависит от величины дефекта барабанной перепонки, целостности и подвижности цепи слуховых косточек и токсического воздействия воспалительного процесса на внутреннее ухо. Глухота при ХГСО часто обусловлена фистулой лабиринта вследствие деструкции кости холестеатомой.

По данным аудиометрии холестеатому распознать невозможно: костно-воздушный интервал не коррелирует с характером разрушения цепи слуховых косточек, а холестеатома и грануляции сами могут проводить звук к внутреннему уху.

3.5 Инструментальные исследования

При ХГСО без холестеатомы для оценки сосцевидного отростка может быть выполнена рентгенография височных костей в укладках по Шюллеру и Майеру.

К нему прибегают только при отсутствии подозрения на холестеатому и осложнённое течение.

Пациентам с ХГСО показана компьютерная томография (КТ) височных костей для оценки их структур.

КТ является методом первичной диагностики. Исследование позволяет оценить распространённость процесса и анатомические особенности (низкое стояние дна средней черепной ямки, высокое стояние луковицы яремной вены, предлежание сигмовидного синуса, дегисценции канала лицевого нерва и лабиринта, перегородка Кёрнера), а также состояние стенок барабанной полости и антромастоидального отдела, цепи слуховых косточек, слизистой оболочки и узких пространств барабанной полости. Исследование выполняют в аксиальной и коронарной проекциях с мультипланарной реконструкцией; оптимальная толщина среза составляет 0,5–0,8 мм.

КТ выявляет признаки ХГСО в 99% случаев, деструкцию стенок среднего уха в 55–97% случаев. Дифференцировать холестеатому от фиброза, грануляций, экссудата и гноя по плотности невозможно: плотность всех этих тканей составляет от +30 до +40 HU. Заподозрить холестеатому в 88% случаев позволяют локализация образования, деструкция стенок барабанной полости, слуховых косточек и антромастоидальной области, расширение входа в антрум, разрушение латеральной стенки аттика или адитуса, дефект задней стенки наружного слухового прохода, разрушение канала лицевого нерва и фистула лабиринта, чаще горизонтального полукружного канала.

При ХГСО без холестеатомы на КТ определяются изменения слизистой оболочки, рубцы вокруг цепи слуховых косточек, в ряде случаев её дефект, чаще вследствие лизиса длинной ножки наковальни. Антрум при мезотимпаните в стадии ремиссии, как правило, пневматизирован; сосцевидный отросток в большинстве случаев компактный, склеротический.

Информативность КТ при оценке оперированного уха низкая: рубцы, грануляции и пластический аутоматериал по плотности не отличаются от холестеатомы. Заподозрить холестеатому позволяет только увеличение «подозрительного» образования в динамике.

Для объективной оценки распространённости процесса КТ проводят не ранее чем через 3–6 месяцев после обострения. КТ в период обострения приводит к необоснованному расширению объёма операции и оправдана только при осложнённом течении.

При подозрении на холестеатому или её рецидив показана магнитно-резонансная томография (МРТ) височных костей.

МРТ в режимах T1, T2, EPI DWI и non-EPI DWI позволяет надёжно выявить холестеатому и её рецидив после операции: чувствительность метода составляет 77–100%, специфичность 86–100%. О холестеатоме свидетельствуют низкий сигнал в режиме T1 и высокий или промежуточный сигнал в режимах T2 и non-EPI DWI. На точность исследования влияет размер холестеатомы; для выявления рецидива МРТ имеет преимущества перед ревизионной операцией и служит ей альтернативой.

Ряд авторов для выявления холестеатомы рекомендует сочетать или совмещать КТ и МРТ: чувствительность в этом случае составляет 96%, специфичность 100%.

При ХГСО с холестеатомой, осложнённом фистулой лабиринта, проводится вестибулометрия.

Исследование необходимо при системном головокружении, неустойчивости и признаках фистулы. Выявление фистулы до операции позволяет предупредить послеоперационные кохлеовестибулярные расстройства.

3.6 Лабораторные исследования

Общеклинические лабораторные исследования необходимы при подготовке к плановой операции.

Показан посев отделяемого из уха на аэробную и факультативно-анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам.

Посев необходим при любой форме ХГСО для подбора этиотропной терапии.

При подозрении на грибковый процесс отделяемое из ушей засевают на дрожжевые и мицелиальные грибы.

Удалённые ткани уха подлежат цитологическому и патоморфологическому исследованию.

Удалённую патологическую ткань во всех случаях направляют на патоморфологическое исследование. При атипичном течении воспаления спектр исследований расширяется для исключения туберкулёза и гранулематоза Вегенера; при отсутствии диагностических данных и неэффективности стандартного лечения исследования повторяются через 3 месяца.

3.7 Консультации специалистов

При сопутствующих заболеваниях и подозрении на осложнение показаны консультации невролога, нейрохирурга и терапевта.

При атипичном течении воспаления и осложнениях может также потребоваться консультация фтизиатра и ревматолога.

---

4. Лечение

Целью лечения является санация среднего уха для достижения стойкой ремиссии и предупреждения осложнений и тугоухости.

4.1 Консервативное лечение

Консервативная терапия проводится при обострении и в рамках подготовки к операции при неосложнённом течении.

Консервативную терапию применяют при обострении для достижения ремиссии перед операцией, а также в раннем периоде после санирующей операции. Она включает бета-лактамные антибиотики, анальгетики, кортикостероиды и процедуры, направленные на улучшение функции слуховой трубы.
При неосложнённом течении лечение амбулаторное, при осложнённом стационарное. В качестве основного метода лечения консервативная терапия носит паллиативный характер и оправдана только у пациентов с тяжёлой сопутствующей патологией при условии регулярного наблюдения.

При сухом перфоративном среднем отите проведение какого-либо лечения не рекомендуется.

> Расхождение в тексте рекомендации: в разделе 3.1 указано, что при сухом перфоративном отите лечение не проводится, тогда как в разделе 3.2 указано, что при перфорации без возможности улучшения слуха тимпанопластику следует выполнять для предупреждения рецидивов, а наилучшие результаты тимпанопластики достигаются именно при сухих перфорациях. В алгоритме (приложение Б) от сухого перфоративного отита стрелки ведут к лечению. Вероятно, запрет относится только к консервативной терапии.

Антибактериальный препарат выбирается с учётом микрофлоры, её чувствительности и способности препарата проникать через гематоэнцефалический барьер. Препаратами выбора являются бета-лактамы (пенициллины и другие бета-лактамные антибиотики), в ряде случаев респираторные фторхинолоны.

К системным препаратам прибегают, как правило, при выраженном обострении и тяжёлых распространённых деструктивных формах. Периоперационная антибиотикопрофилактика должна соответствовать характеру и объёму операции.

При смешанной микрофлоре рекомендацией предусмотрено сочетание 2–3 препаратов, например цефалоспоринов и фторхинолонов. Допускается сочетание местных противомикробных препаратов с противогрибковыми.

Основная роль в лечении принадлежит местным средствам: антисептикам, ушным противомикробным препаратам, местным противогрибковым средствам и кортикостероидам в комбинации с противомикробными препаратами. Наиболее эффективными и безопасными являются топические фторхинолоны: к ним чувствительны 75,6% возбудителей, они не обладают ототоксичностью и допустимы при перфорации. Местное лечение эффективно только после тщательного удаления содержимого из среднего уха аспирацией или промыванием.

Грануляции в барабанной полости по возможности удаляются или прижигаются соединениями серебра; кроме того, они хорошо регрессируют под действием топических кортикостероидов.

Кортикостероиды в каплях или в составе комбинированных препаратов используют при вялотекущем воспалении слизистой оболочки (мукозите). При неэффективности местного лечения в течение 1–3 месяцев, что характерно для мукозита, показано хирургическое вмешательство с дренированием.

При холестеатоме эффективно местное применение препаратов борной кислоты: помимо антисептического действия, они оказывают подсушивающее действие на ткани и тем самым уменьшают воспаление.

При грибковой флоре противомикробные препараты и кортикостероиды в каплях противопоказаны. Ведение таких пациентов осуществляется строго по алгоритмам применения местных противогрибковых средств; лечение часто длительное и требует участия миколога.

> Расхождение в тексте рекомендации: абзацем выше допускается сочетание противомикробных ушных препаратов с противогрибковыми, тогда как при грибковой флоре противомикробные капли противопоказаны. Кроме того, «антибиотики для наружного применения» обозначены кодом ATX D01A, который относится к противогрибковым препаратам.

Дисфункцию слуховой трубы устраняют поэтапно. На первом этапе осуществляется лечение заболеваний полости носа и носоглотки, от назначения деконгестантов и назальных кортикостероидов до хирургического вмешательства. Затем восстанавливается проходимость слуховой трубы продуванием по Политцеру или курсом катетеризаций с введением лекарственных препаратов. На заключительном этапе восстанавливается активное открытие и закрытие слуховой трубы с помощью специальной гимнастики или электростимуляции её мышц.

4.2 Хирургическое лечение

Основным методом лечения ХГСО является хирургический: только операция позволяет полностью санировать ухо и улучшить качество жизни, поэтому каждый пациент с ХГСО рассматривается как потенциальный кандидат на хирургическое лечение. Операцию выполняют в период ремиссии, не ранее чем через 3–6 месяцев после последнего обострения; в этом случае объём вмешательства меньше, а операция безопаснее и эффективнее.

Вынужденное вмешательство при обострении или осложнении ограничивается санацией среднего уха открытого типа, при внутричерепных осложнениях расширенной; вследствие кровоточивости тканей такая операция технически сложна и чаще сопровождается ятрогенными осложнениями. Пациентов с осложнениями оперируют в ургентных отделениях, вне обострения в специализированных отделениях и центрах, владеющих реконструктивной хирургией среднего уха. Ранняя операция на «сухом ухе» обеспечивает более полную санацию очага, сохранение слуха и анатомических структур и сокращает сроки реабилитации.

При ХГСО с мукозитом II и III степени выполняются дренирующие операции.

Методика определяется индивидуально с учётом формы ХГСО и распространённости процесса, анатомии височной кости, степени тугоухости, состояния слуховой трубы, наличия осложнений и опыта хирурга.

Для санации среднего уха и улучшения слуха выполняется тимпанопластика.

При мезотимпаните применяют тимпанопластику различных типов и миринготимпластику в зависимости от степени разрушения цепи слуховых косточек; применяются протезы из хряща, наковальни, кортикальной кости, титана, для пластики барабанной перепонки используются аутоматериалы. Вмешательство проводят через наружный слуховой проход, эндауральным или заушным доступом, под местной анестезией или наркозом, под контролем эндоскопа или микроскопа, в один или два этапа.

Результат зависит от срока после последнего обострения, изменений в среднем ухе, локализации и размера перфорации, функции слуховой трубы и состояния слизистой оболочки, способа реконструкции, опыта хирурга и послеоперационного ведения. Обязательным условием успешной тимпанопластики является отсутствие выделений из уха в течение не менее 3–6 месяцев.

Тимпанопластика эффективна в 43–98% случаев, риск глухоты на оперированное ухо составляет 1–2%. Наилучшие результаты (у 93,3% пациентов) достигаются при сухих перфорациях независимо от техники укладки трансплантата.

У пациентов без холестеатомы мастоидотомия при тимпанопластике не улучшает ни анатомический результат, ни аэрацию сосцевидного отростка, но увеличивает объём и риск вмешательства. Обязательной она считается при вялотекущем хроническом перфоративном отите без холестеатомы в случае неэффективности системной и местной антибактериальной терапии.

Применение эндоскопа в дополнение к микроскопу улучшает обзор барабанной полости, однако, по данным систематического обзора, преимущества исключительно эндоскопических операций перед микроскопическими не доказаны.

При тотальных и субтотальных дефектах барабанной перепонки с изменённой слизистой оболочкой большинство хирургов для профилактики реперфорации сочетают аутофасцию, аутохрящ и кожные трансплантаты. Тонкие пластинки аутохряща препятствуют ретракции и не ухудшают акустические свойства.

При мукозите тимпанопластика оправдана: после восстановления функции слуховой трубы и аэрации утолщённая слизистая оболочка нормализуется. Слизистая оболочка удаляется инструментально или с помощью лазера. При выраженном мукозите лучшие результаты достигаются при оставлении дренажной трубки под меатальным лоскутом или при вскрытии антрума с дренированием через него барабанной полости на срок до 2 недель.

Второй этап тимпанопластики проводят через 8–12 месяцев. При наличии перфорации без возможности улучшения слуха тимпанопластика также показана для предупреждения рецидивов ХГСО.

Искусственные протезы и аутопротезы при оссикулопластике не различаются по слуховым результатам, однако искусственный протез без прикрытия аутохрящом смещается в 6 раз чаще.

4.3 Санирующие операции при холестеатоме

При ХГСО с холестеатомой выполняются санирующие операции.

Основным принципом является полное удаление холестеатомы и устранение причин рецидива.

При эпитимпаните и эпимезотимпаните с холестеатомой в зависимости от распространённости процесса выбирают «открытые», «полуоткрытые» или «закрытые» санирующие операции с тимпанопластикой или без неё. С учётом объёма и длительности вмешательства операции выполняют под общей анестезией.

При холестеатоме, ограниченной аттиком или аттиком и адитусом, допустима аттикотомия через наружный слуховой проход при обязательном тщательном удалении патологического процесса из синусов и карманов среднего уха.

«Открытая» техника (с удалением задней стенки наружного слухового прохода) избавляет от повторных операций, но не от регулярного ухода за полостью у оториноларинголога. После «закрытой» операции обязательна ревизия через 8–12 месяцев или МРТ для исключения рецидива. «Закрытые» операции сопряжены с более высоким риском внутричерепных осложнений, поэтому при невозможности постоянного послеоперационного наблюдения предпочтительна «открытая» методика.

«Закрытые» методики (аттикоадитотомия, аттикоантротомия, раздельная антромастоидотомия) предпочтительны при ограниченной холестеатоме; «открытые» методики (модифицированная радикальная, консервативно-радикальная, общеполостная операция, антромастоидотомия с удалением задней стенки, радикальная мастоидэктомия) предпочтительны при распространённой деструкции, активной холестеатоме или вялотекущем обострении.

Современной тенденцией является применение «полуоткрытой» (гибридной) техники: аттикоантро- или мастоидотомии с облитерацией антрума и сосцевидного отростка аутотканями или инертными материалами и тимпанопластикой. При этом анатомия уха остаётся близкой к исходной, болезнь послеоперационной полости не развивается и необходимость в пожизненном наблюдении отсутствует.

При выявлении рецидива холестеатомы после «закрытой» операции объём вмешательства расширяется до антромастоидотомии с удалением задней стенки наружного слухового прохода и формированием открытой полости.

После операции наружный слуховой проход тампонируют с противомикробными препаратами: после тимпанопластики на 10–14 дней, после санирующей операции на 14–21 день; дополнительно необходимо медикаментозное и физиотерапевтическое воздействие на слуховую трубу и слизистую оболочку. Важное значение имеет квалифицированное наблюдение в отдалённом периоде.

4.4 Слухопротезирование

При асоциальном слухе (тугоухость выше II степени) и отсутствии возможности его улучшения показана электроакустическая реабилитация.

Слухопротезирование показано при порогах костной проводимости выше 30 дБ на оба уха, в том числе в отдалённом послеоперационном периоде.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Пациенты, которым операция противопоказана или отложена, а также отказавшиеся от неё, наблюдаются специалистом поликлиники раз в 6 месяцев; при обострении применяют консервативное лечение.

После тимпанопластики и санирующих операций пациент ежегодно на протяжении не менее 5 лет осматривается врачом поликлиники и отохирургом клиники, в которой выполнялась операция. Цель наблюдения состоит в своевременном выявлении рецидива перфорации, холестеатомы и тугоухости.

Профилактика обострений включает санацию полости носа и носоглотки, разъяснение пациенту характера заболевания, обучение защите уха от попадания воды и предупреждению обострений при ОРЗ, а также своевременному обращению к врачу поликлиники и в клинику, где выполнялась операция.

В послеоперационном периоде в зависимости от методики рекомендуется постельный режим с положением на противоположном ухе. В течение месяца следует избегать физических нагрузок, в течение 3 месяцев авиаперелётов; ухо необходимо защищать от попадания воды до завершения реабилитации.

5.1 Показания к госпитализации и выписке

Первичный осмотр пациента выполняют оториноларинголог и сурдолог-оториноларинголог.

Показанием к экстренной госпитализации является обострение ХГСО с внечерепными или внутричерепными осложнениями.

Плановая госпитализация для хирургического лечения показана при ХГСО, в том числе с холестеатомой, в стадии вялотекущего воспаления или ремиссии продолжительностью не менее 3–6 месяцев. Показаниями являются снижение слуха с шумом в ухе, снижение слуха со скудным отделяемым, не купирующимся консервативной терапией, или любые клинические проявления ХГСО независимо от вида тугоухости при отсутствии общих противопоказаний и при условии обследования пациента в соответствии с требованиями стационара.

После экстренной госпитализации пациент выписывается при отсутствии угрозы жизни и восстановлении жизнедеятельности, после плановой в зависимости от объёма операции и самочувствия: на 3–5-е сутки после завершения противовоспалительной и симптоматической терапии, с тампонами в наружном слуховом проходе. Тампоны удаляются амбулаторно через 2–3 недели, контроль слуха по данным ТПА осуществляют амбулаторно через 3 и 12 месяцев.

Эффективность лечения оценивается по жалобам на снижение слуха и выделения из уха, по данным отоэндоскопии (закрытие перфорации, отсутствие отореи, эпидермизация полости), ТПА, КТ или МРТ (санация уха, отсутствие деструкции и холестеатомы), а также по данным вестибулометрии при фистуле лабиринта.

ХГСО приводит к прогрессирующей тугоухости и осложнениям: лабиринтиту, периферическому парезу лицевого нерва, менингиту, абсцессу мозга и тромбозу сигмовидного синуса.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Хронический средний отит»
Версия	2-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 29.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По правилу из приложения А2 КР — не реже одного раза в три года: следующая версия ожидается не позднее октября 2027 года
Код в рубрикаторе	698_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- При сухом перфоративном среднем отите раздел 3.1 исключает любое лечение, тогда как раздел 3.2 и алгоритм в приложении Б предусматривают при перфорации тимпанопластику.
- Сочетание противомикробных ушных препаратов с противогрибковыми допускается, однако при грибковой флоре противомикробные капли противопоказаны; «антибиотики для наружного применения» обозначены кодом противогрибковых препаратов D01A.
- Сроки тампонады после операции различаются: в разделе 3.2 указано 10–14 дней после тимпанопластики и 14–21 день после санирующей операции, в разделе 6 указано удаление тампонов через 2–3 недели.
- Название и коды МКБ охватывают и негнойные формы (H65.2–H65.4), однако определение и весь текст рекомендации посвящены только хроническому гнойному среднему отиту.